ONEMA-POP-044 — Versão institucional 1.0

Status: Aprovado pelo RT · Vigência: 09/11/2026 · Responsável técnico: Enf. Marcos Roberto Alves, COREN-SP 983558

ONEMA-POP-044 — Triagem Remota de Cefaleia Aguda e Sinais de Alarme

1. Identificação institucional

técnica

2. Objetivo e abrangência

Padronizar a atuação de enfermagem em: Triagem Remota de Cefaleia Aguda e Sinais de Alarme. Aplicável a visitas e/ou triagem digital conforme pertinência, sem substituir serviço de emergência.

3. Competência, indicações e contraindicações

Enfermeiro habilitado, treinado e autorizado; Cefaleia aguda em teletriagem ou visita; excluir sinais de hemorragia, meningite, AVC e outras causas secundárias. Não realizar intervenções além da competência, prescrição ou recursos disponíveis.

4. Materiais e equipamentos; fornecimento

Enfermeiro: aparelho de PA, termômetro e avaliação neurológica na visita; paciente: histórico de cefaleias e medicações. Equipamentos de avaliação clínica de uso profissional são providos pelo enfermeiro; consumíveis do paciente conforme contratação.

5. Avaliação clínica e preparação

Início súbito ou progressivo, pior cefaleia da vida, febre, rigidez de nuca, trauma, gravidez/puerpério, anticoagulação e déficits focais. Confirmar identificação, consentimento, privacidade e localização para eventual emergência.

6. Execução técnica individualizada

1. Confirmar início e tempo até intensidade máxima; perguntar se atingiu pico em segundos/minutos.

2. Investigar déficit focal, alteração de fala/visão, confusão, síncope, convulsão, febre e rigidez cervical.

3. Identificar gravidez/puerpério, idade avançada com cefaleia nova, imunossupressão, câncer e anticoagulantes.

4. Na visita, aferir PA, temperatura, consciência e exame neurológico focal compatível com competência.

5. Se cefaleia em trovoada ou sinal neurológico/infeccioso grave, acionar SAMU 192 imediatamente.

6. Não orientar automedicação que atrase avaliação de cefaleia com sinais de alarme.

7. Na ausência de alarmes, orientar avaliação clínica conforme apresentação e documentar critérios negativos.

8. Confirmar retorno e sinais de piora, registrando horário de encaminhamento e destino.

7. Interrupção, intercorrências e encaminhamento

Cefaleia súbita intensa, déficit neurológico, meningismo, rebaixamento ou convulsão: emergência.

8. Cuidados posteriores e orientações

Orientar não dirigir em suspeita de emergência e informar horário de início dos sintomas.

9. Registros obrigatórios na Carteira Digital ONEMA

Registrar identificação, data/hora, modalidade, consentimento, queixa, avaliação, achados positivos/negativos, etapas realizadas, intervenções não realizadas e justificativa, comunicação com RT/rede, encaminhamento, orientações, plano de retorno e assinatura do enfermeiro.

10. Referências específicas e rastreáveis

 COFEN — Resolução 736/2024, Processo de Enfermagem — https://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-736-de-17-de-janeiro-de-2024/

 NICE CG150 — Headaches in over 12s: diagnosis and management — https://www.nice.org.uk/guidance/cg150

Referências consultadas como suporte temático; a correspondência exaustiva entre cada passo e a evidência, bem como regras locais e manuais dos fabricantes, requer análise pelo RT.